

Pédodontie

Fascicule 12 · Soins adaptés à l'enfant — psychologie, accueil, soins spécifiques

Principe : les soins sont les mêmes que chez l'adulte mais doivent être adaptés. Tout débute par **instaurer un climat de confiance** dès le 1er RDV.

Psychologie de l'enfant — par âge

Approche selon l'âge

Indications : À adapter à chaque tranche d'âge

Étape	Matériel
Très jeune enfant	Peur de l'inconnu · sensible aux stimuli brutaux (bruits, mouvements)
3-4 ans (1re année maternelle)	Craint la séparation — ne pas séparer des parents
4-6 ans (années maternelles)	Peur des atteintes corporelles
7 ans	Désire tout comprendre · environnement familial primordial
8-14 ans	Comprend les soins et leur importance · impact familial fort

Accueil au cabinet — règles d'or

Cadre d'accueil

Indications : L'AD est centrale dans la mise en confiance

Étape	Matériel
Préparation	Climat de confiance dès le 1er RDV · cadre gai et accueillant
Horaire	RDV le matin (enfant reposé) plutôt que le soir après l'école
Communication	S'adresser directement à l'enfant · voix calme mais ferme · mots choisis
À éviter (anxiogène)	« N'aie pas peur », « Ne t'inquiète pas », « Ça ne fait pas mal », « Il va te faire une piqûre »
Praticien	Gestes rapides et précis · féliciter et rassurer · ne pas hésiter à interrompre
Rôle AD	Côté rassurant (vs praticien) · aide précieuse pour l'aspiration · main du praticien doit quitter le moins possible la bouche

Soins chez l'enfant — adaptations

Matériau de choix dents temporaires : CVI (mise en œuvre plus aisée, ne craint pas la salive). **Pulpotomie privilégiée** pour les dents temporaires (rapide, résultats satisfaisants pour la longévité).

Traitements spécifiques des dents permanentes immatures

Apexogénèse

Indications : Pulpotomie sur dent permanente immature — préserve la vitalité pulpaire dans les racines pour permettre la fin de l'édification radiculaire

Étape	Matériel
Anesthésie	Plateau anesthésie
Pose de la digue	Feuille de digue · pince Ainsworth · clamp · pince Brewer · cadre Young
Éviction carieuse	Turbine + diamantée · CA bague bleue + CT · excavateur
Pulpotomie	Élimination de la pulpe camérale (excavateur ou fraise stérile)
Hémostase	Compresse stérile humide · sérum physiologique
Obturation chambre pulpaire	Biomatériau (MTA, Biodentine...) — clé pour préserver la vitalité
Obturation définitive	CVI ou composite

Apexification

Indications : Traitement canalaire d'une dent permanente immature à pulpe nécrosée — formation d'une barrière apicale

Étape	Matériel
Anesthésie + digue	Idem
Cavité d'accès	Turbine + fraise endo · fraise boule
Désinfection canalaire	Limes endo · irrigation hypochlorite de sodium
Mise en place barrière apicale	Hydroxyde de calcium (Ca(OH) $\blacksquare$) en plusieurs séances OU MTA en monobloc apical
Obturation canalaire différée	Gutta-percha + ciment de scellement
Obturation coronaire	CVI ou composite

À retenir : apexogénèse = pulpe vivante à protéger (biomatériau coiffant). Apexification = pulpe nécrosée à remplacer (Ca(OH) $\blacksquare$ ou MTA pour créer une barrière).